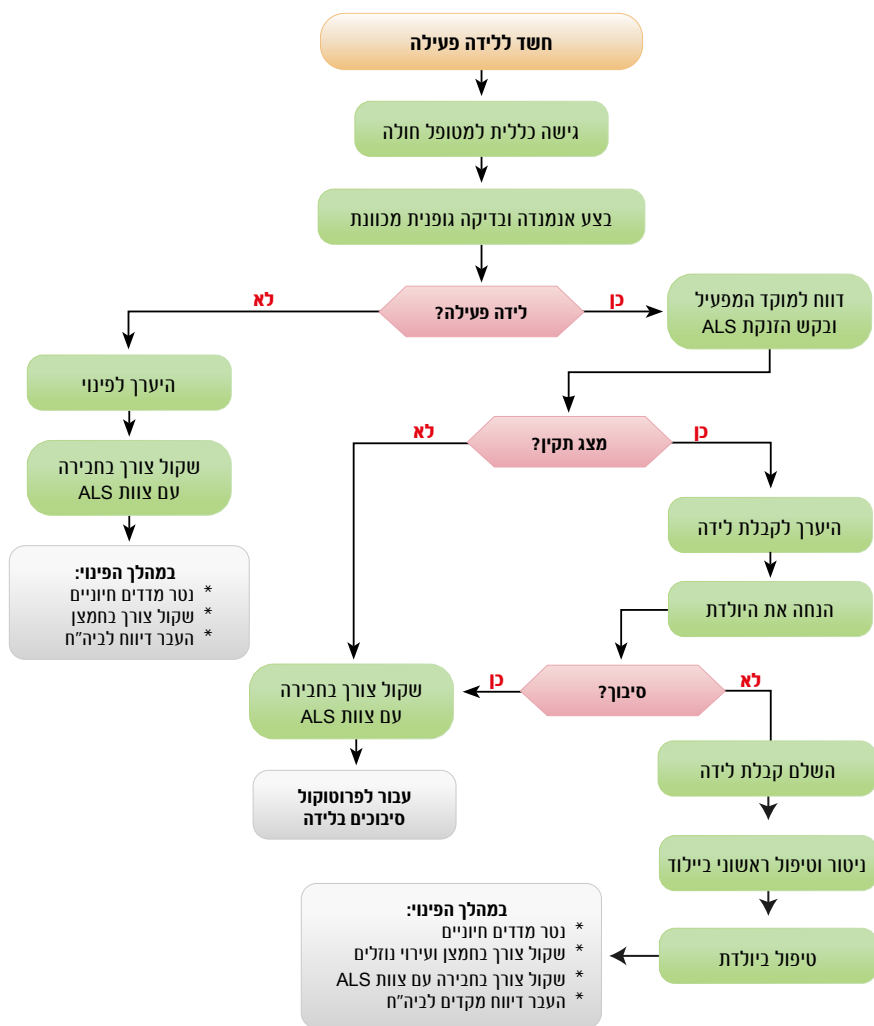


קבלת לידה



דגשים:

אומנדה

- * גיל ההיריון
- * לידות בעבר (לרבות מוקדמות)
- * ניתוח קיסרי בעבר
- * מעקב היריון - סיבוכים ידועים (כגון: סוכרת, רעלת נד')
- * מספר עוברים? מנח?
- * תדירות ומשך הצירים
- * ירידת מים? מים מקוואליים? דימום וגניאלי?

לידה פעילה

- * צירים סדירים וארוכים
- * לחץ חזק באיזור הפרינאום
- * דחף חזק לביצוע לחיצות
- * Crowning

לידה חבירה עם צוות ALS

- * זמן ומרחק מביה"ח
- * סיכון צפוי או שהתפתח במהלך הלידה.
- * צורך בטיפול מיוחד ביילוד או באם לאחר הלידה

לפני ובמהלך הלידה

- * הנן ציווד נדרש לקבלת לידה, טיפול ביילוד וטיפול ביולדת.
- * דאג לסביבה נקייה, נוחה ומחוממת ושמור על צנעת היולדת ככל הניתן.
- * הנחה את היולדת לביצוע לחיצות מתואמות עם הצירים.
- * שקול ביצוע בסקשן ליילוד במקרה של מים מקוואליים.

סיבוכים נפוצים (פרוטוקול נפרד)

- * מצג חריג (עכוז, גפה, רוחבי)
- * פרע כתפיים/לידה שאינה מתקדמת
- * שמש חבל הטבור
- * חבל טבור כרוך סביב צוואר היילוד

תרשים 16.1 תרשים זרימה של פרוטוקול קבלת לידה

תשאול הילדת

- (1) באיזה שבוע ההיריון?
- (2) מה תדירות צירים ומשכם?
- (3) מתי אירעה ירדת מים?
- (4) האם נצפו מים מקונואליים?
- (5) האם יש צורך בריקון מעיים?
- (6) מה מספר העוברים?
- (7) האם מהלך ההיריון היה תקין?
- (8) האם האישה נמצאת במעקב היריון מרובה סיכונים?
- (9) כמה הריונות או לידות היו בעבר? האם היו הפלות קודמות?
- (10) האם האישה מוזמנת לניתוח קיסרי?
- (11) מצג העובר

המגמה היא לקבל לידה בבית חולים, בתנאים אידיאליים.

שלב הלידה

שלב ראשון - מחיקה ופתיחה של צוואר הרחם, ירדת מים

צירים הם התכווצויות סדירות ומחזוריות של שריר הרחם המתרחשות לאורך כל הלידה. לא ברור בדיוק מה גורם להם. הצירים מתחילים בחלק העליון של הרחם והם הולכים ויורדים כלפי מטה. תדירותם הולכת וגדלה והכאבים מתגברים. אם יש יותר מעובר אחד, סיכויי ההיריון גדלים פי 2. אם יש צירים כל שתי דקות, פירוש הדבר שהאישה ההרה מוכנה ללדת וצריך לקבל את הלידה. ירדת המים אינה מרמזת על מועד הלידה, ויכולה להיות ירידה של מים ללא צירים.

שלב זה יכול להימשך 8-16 שעות ואף יותר בלידה ראשונה. לידה ראשונה היא לרוב איטית יותר וקשה מהלידות הבאות. הלידות הבאות נעשות קלות ומהירות יותר.

שלב שני - צירים ולידת הוולד

בשלב זה משך כל ציר 30-60 שניות. הצירים תכופים מאוד וסדירים ויש עלייה הדרגתית בעוצמתם. בודקים אם רואים crowning. זהו מצב שבו ראש התינוק נמצא בפתח תעלת הלידה. בשיא הציר, השפתיים החיצוניות נפתחות קצת ואפשר לראות את קצה ראש התינוק. משמעות הדבר שהלידה קרובה מאוד. כשראש הוולד יוצא מהרחם הוא לוחץ על הרקטום וגורם להרגשה של צורך להוציא צואה, ולכן חשוב לשאול את היולדת אם היא מרגישה כך.

שלב זה יכול להימשך בין שתיים לשלוש.

שלב שלישי - לאחר שהוולד יוצא

חבל הטבור נחתך ומופרד והשליה יוצאת, הסתיימה הלידה. יש להוציא את חבל הטבור בשלמותו מחשש לקריעת השליה ולדימום. יש להעביר את השליה במכל המיועד לכך לבית החולים, לבדיקת שלמותה.

הציוד הנדרש

- ערכת לידה, חשוב לשמור על סטריליות
- ערכת עירוי
- ציוד החייאה למבוגר
- ציוד להחייאת יילוד
- חמצן
- מגבות

הכנת היולדת ללידה

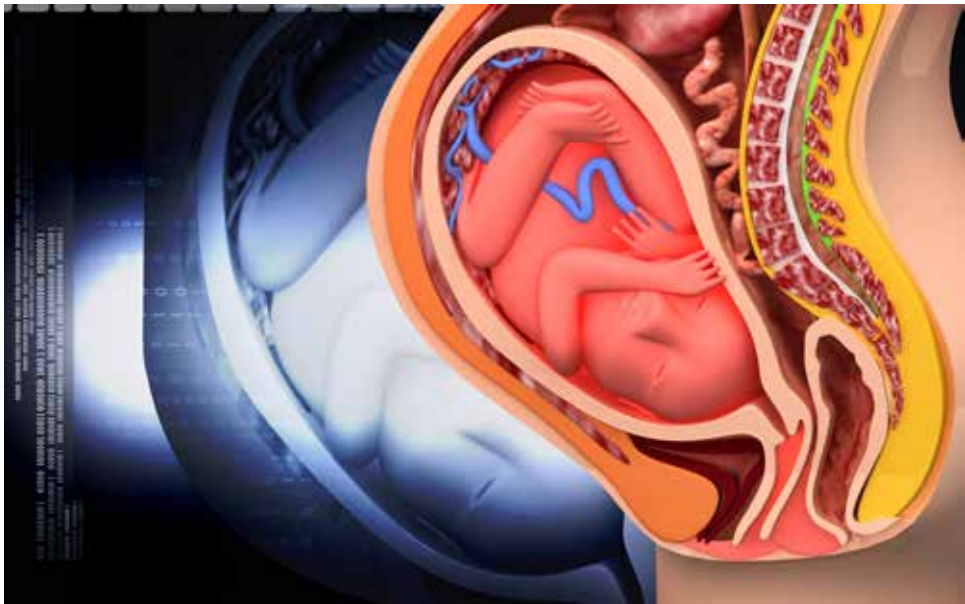
- מרגיעים את היולדת ושומרים על פרטיותה
- פותחים וריד לפי הפרוטוקול
- מכסים את היולדת בסדינים סטריליים
- מודדים סימנים חיוניים

דגשים ללידה

- מניעת לידת "פיצוץ" - יש לדאוג שהאישה מפסיקה ללחוץ לאחר יציאת ראשו של היילוד.
- מחממים את החדר או האמבולנס
- שואבים הפרשות רק אם יש חסימה של דרכי האוויר
- שומרים את הוולד בגובה היולדת (כל עוד השליה לא התנתקה מהיילוד הדבר מונע הפרשי לחצים ושינויים פתאומיים בנפח הדם של היילוד)
- מנתקים את חבל הטבור לפי הפרוטוקול
- מייבשים את היילוד ושומרים על חום גופו
- תומכים ביולדת ברציפות
- ממלאים טופס מטופל נפרד לוולד
- מבקשים שיתוף פעולה מהאישה רק כשיש לה צירים (מבקשים ממנה ללחוץ ולדחוף)
- אם יוצאת צואה, תופסים אותה עם פד גזה ומכסים
- אפשר להכניס אצבע ולפשק את השפתיים החיצוניות כדי לעזור לראש היילוד לצאת
- הוולד תמיד יוצא עם הראש כלפי מטה ועושה סיבוב חיצוני כלפי מעלה. כשהראש יוצא תומכים בצוואר ביד, מחזיקים את הראש ומבקשים מהאישה לא ללחוץ
- שואבים הפרשות מהפה והאף של היילוד אם יש חסימה
- מושכים כלפי מעלה, היד השנייה מחליקה לאורך הוולד, תומכת בו ותופסת אותו בין הרגליים ושומרים שהוא בגובה האם (איור 16.16)

זהירות, תינוקות שזה עתה נולדו הם חלקים. יש להיזהר שהיילוד לא ייפול.

- עם התחלת הנשימה, התינוק נעשה ורוד, בהתחלה הראש, הכתפיים, הבטן והרגליים.
- על חבל הטבור שמים קליפ כ-10 ס"מ מהתינוק, וקליפ נוסף בערך 5 ס"מ מהראשון. חותכים במספרים בין הקליפסים (חשוב לבדוק שאין נזילה של דם ואם יש שמים עוד קליפ).
- מנגבים את התינוק ועוטפים אותו, נותנים אותו לאם כדי שיחפש שד כי הנקה מכווצת את הרחם.



איור 16.16 מצג ראש של העובר

מצג ראש, המצג הרצוי ביותר, קודקוד התינוק מוביל ויוצא ראשון.

הדגשים בלידת שליה

- לא לעכב פינוי אם יציאת השליה מתעכבת
- לא למשוך את השליה
- בודקים דימומים מהשליה
- שומרים את השליה בכלי המיועד לכך
- הנקה מכווצת את הרחם

לאחר לידת השליה, לוקחים פדים, מניחים אותם בין רגלי היולדת ומבקשים ממנה לשלב רגליים כדי לספוג את הנוזלים שיצאו עם התינוק.

מבחן אפגר (APGAR)

כדי לבדוק את מצב היילוד יש לעשות את מבחן אפגר פעמיים: דקה אחרי הלידה וכעבור 5 דקות. מטרת הבדיקה היא לבדוק שהוא לא במצוקה. בודקים חמישה פרמטרים: צבע העור, דופק, תגובה למגע, טונוס שרירים, נשימה. לכל תוצאה נותנים ניקוד מ־0 עד 2. לפי הטבלה.

ציון 7–10 פירושו שהתינוק במצב טוב

ציון 4–6 פירושו שהתינוק זקוק להתערבות רפואית מסוימת

ציון 0–4 פירושו שהתינוק זקוק לטיפול רפואי מיידי

טבלה 16.1 מבחן אפגר (APGAR)

הבדיקה	APGAR	0 נקודות	נקודה 1	2 נקודות
צבע העור	Appearance	ולד כחול כולו	גפיים כחולות	ולד אדום כולו
דופק הלב	Pulse	אין דופק	מתחת ל־100 בדקה	מעל 100 בדקה
תגובה למגע (הבעת הפנים)	Grimace	אין תגובה	תגובה קלה	תנועה מרובה
טונוס שרירים	Activity	אין תנועה	תנועה קלה	תנועה מרובה
נשימה	Respirations	אין נשימה	נשימות איטיות ובכי מועט	בכי חזק

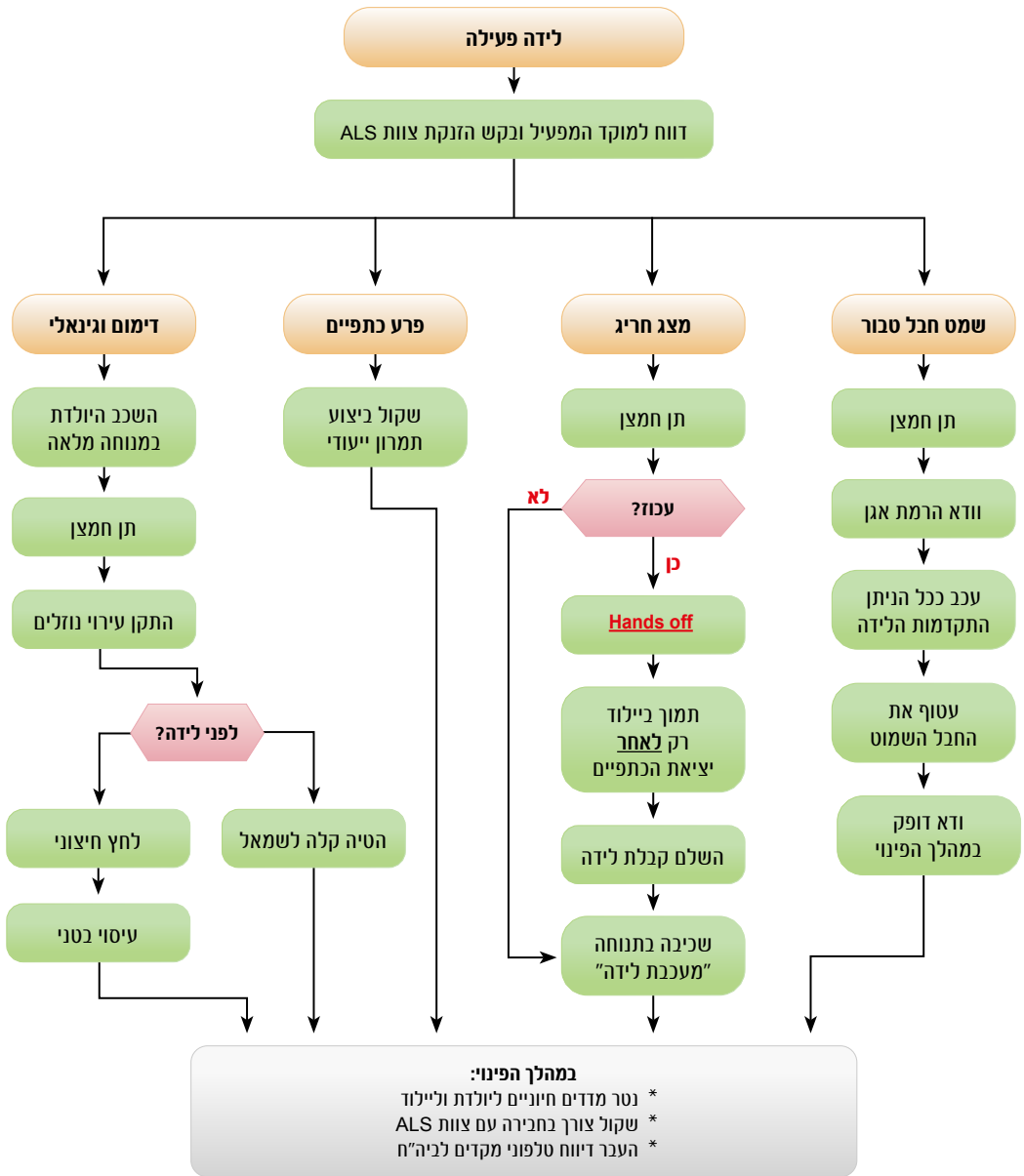
מים מקוניאליים

אלו מי שפיר בצבע חום ירקרק, חום או צהוב, עם ריח לא נעים של חלב חמוץ במקום מים צלולים ושקופים. מים מקוניאליים מעידים על כך שבמים אלו יש צואה של העובר. אם העובר נכנס למצוקה בהיריון הוא עושה את צרכיו במי שפיר.

חשוב מאוד לרשום עובדה זו כי המידע חשוב להמשך הטיפול בולד (נקרא מקוניום). במקרה זה הוולד יקבל בבית החולים אנטיביוטיקה מחשש לדלקת ריאות. שאיפה של מקוניום לריאות הוולד יכולה לגרום לנזק ריאתי קשה מאוד ולהתפתחות ARDS.

לעיתים נוצר פקק של דם בתחתית הרחם. בזמן שלפני הלידה יכול ליפול הפקק וייתכן שיופיע דימום.

חשוב לשאול את היולדת כמה דיממה, מה צבע הדם ואיזה שבוע בהיריון (תרשים מס' 16.2).



תרשים 16.2 הגישה הטיפולית למצבי חירום במיילדות

מצבי חירום גינקולוגיים

כללים ברפואה

- אצל כל בת/אישה בגיל 8-80 שנה שמתלוננת על כאב בטן יש לחשוד שקיימת בעיה גינקולוגית עד שלא הוכח אחרת.
- מטפל ששוכח לחפש סיבה גינקולוגית לאישה בגיל הפוריות שמתלוננת על כאב בטן יחמיץ לפחות 50% מהאבחנות האפשריות.
- טעות באבחנה יכולה להיות הרת אסון.

הערכת מצב המטופלת

- הערכה זהירה ונכונה של אישה המתלוננת על כאב בטן תבטיח טיפול קדם־ניתוחי מתאים.
- לא תמיד אפשר לעשות אבחנה מדויקת בשטח אבל הערכה זהירה תאפשר לצוות קדם־בית חולים להעריך את מצבה של המטופלת ולהתחיל טיפול מציל חיים במידת הצורך.

הדגשים ללקיחת האנמנזה

מתמקדים ראשית בתלונה העיקרית. כאשר התלונה העיקרית היא כאב בטן, מבררים פרטים נוספים על הכאב. הדרך היעילה ביותר לעשות זאת היא על פי טבלת PQRST-A.

טבלה 16.2 טבלת PQRST-A לבירור כאבי בטן

אות	משמעות	פירוט
P	Provoked	מה עורר את הכאב? האם יש גורמים שמחמירים את הכאב? למשל: קרע של ציסטה בשחלה, הכאב יופיע במאמץ. אצל אישה עם PID הכאב יופיע בזמן קיום יחסי מין.
	גירוי, עירור לבעיה	
Q	Quality	מה איכות הכאב? עמום? חד? עוויתי? למשל: במטופלת עם הפלה טבעית הכאב יהיה עוויתי. לעומת זאת כאב של PID (דלקת זיהומית באגן) נוטה להיות עמום וקבוע.
	איכות	
R	Region/ Radiation	מהו אזור הכאב? האם הכאב מקרין? למשל: בהיריון מחוץ לרחם הכאב נמצא בתחילה בצד אחד של הבטן ולאחר מכן מתפשט. אם יש הקרנה לכתף - סימן לכמות דם גדולה בבטן. כאב בקו האמצע של הבטן - משמעותו כנראה הפלה טבעית. כאב מפוזר בבטן תחתונה - PID.
	הישנות/ הקרנה	
S	Severity	מה חומרת הכאב? למשל: כאב חזק מאוד מעיד על בעיה חוץ־גינקולוגית, כמו כאב מהשופכה - urethral pain או קרע (דיסקציה) באאורטה - aortic dissection.
	חומרה	
T	Timing	זמן הכאב? מתי החל הכאב? איזה קשר יש בין הזמן ובין הכאב לדימום וגינאלי, מה קדם למה? למשל: ב־PID הכאב מופיע זמן קצר לאחר הווסת. בהיריון מחוץ לרחם הכאב מתפתח בדרך כלל לפני הדימום. בהפלה טבעית הכאב בדרך כלל מופיע לאחר הדימום.
	תזמון	

בהמשך יש לשאול לגבי דימומים וסימפטומים המעידים על איבוד דם משמעותי כמו סחרחורות, זיעה, חולשה. • מתי הייתה הווסת האחרונה? האם היה דימום רגיל או שוני בדימום? שוני בכאבים המתלווים? שוני במשך הדימום? שוני במרקם? האם היה דימום או הכתמה בין הווסתות? חוסר וסת באישה בגיל הפוריות משמעותו היריון עד שלא הוכח אחרת. • האם האישה חושבת שהיא בהיריון? תשובה שלילית להיריון אינה תמיד מהימנה. • האם יש סימפטומים של היריון? גודש או רגישות בשדיים, שכוחות יתר במתן שתן, בחילות או הקאות בבקרים. • האם האישה משתמשת באמצעי מניעה? נשים עם התקן תוך־רחמי מועדת ל־PID ולהיריון מחוץ לרחם. גלולות למניעת היריון - הן גורם סיכון למחלות כבד ומרה. לנשים ללא אמצעי מניעה הפעילות מינית יש סיכוי גבוה להרות. • האם היה דימום וגינאלי כלשהו? אם כן, באיזה צבע (בהיר או כהה)? מתי התחיל? מה הכמות? • האם היו הפרשות וגינאליות? אם כן, כמה? באיזה צבע? האם לוו בריח רע? מהי ההיסטוריה המיילדותית? • כמה הריונות היו לה? כמה לידות? האם היו בעיות גינקולוגיות בעבר? דימומים, זיהומים, הפלות. האם ברקע יש עוד מחלות כרוניות? סוכרת, יתר לחץ דם (יל"ד), מחלות לב וכלי דם אחרות. • האם נטלת תרופות בקביעות או לא קבוע? האם רגישה לתרופות שונות?	Additional Complaints/ Associated Symptoms תלונות וסימפטומים נוספים	A
--	---	----------

אישה עם בעיות גינקולוגיות עלולה להיות נבוכה או לחשוש לענות, דבר הדורש הבנה מקצועית ורגישות כדי לקבל אנמנזה טובה.

בדיקה פיזיקלית

- בבדיקה פיזיקלית יש שאלה עיקרית אחת: האם המצב מסכן חיים מיידית?
 - באישה עם כאב בטן או דימום וגינאלי מחפשים קודם כול סימני הלב.
- נוסף על בדיקה הפיזיקלית הנעשית לכל מטופל ומטופלת, בנשים יש לשם דגש על הדברים האלה:
- **הערכה חיצונית כללית** - האם האישה נראית מתוחה או חוששת?
 - **בדיקת העור והממברנות** - מה מצב העור? חם, קר, יבש, לח, חיוור, כחול, צהוב, מנומר.

סימנים חיוניים:

- **נשימה** - איך, כמה, מה איכות הנשימה?
- **לחץ דם** - בדרך כלל נמוך בנשים בהיריון.
- **דופק** - בדרך כלל מהיר מהרגיל בהיריון.
- **שינויים אורתוסטטיים, בשכיבה ובעמידה** - בודקים דופק בשכיבה ובעמידה. אם היחס עובר מספר של 20 דפקים סימן שיש בעיה אורתוסטטית. פירוש הדבר שהאישה מיובשת וחסרים לה נוזלים. שינויים כאלה מחשידים להלם. כך גם לגבי הפרש של יותר מ-10 ממ"מ (ממ"מ) בין לחץ דם בשכיבה ובעמידה.
- **בדיקה מהירה של הבטן** - הדבר החשוב ביותר בבדיקות הבטן הוא אם הבטן רכה או קשה.

טראומה בנשים הרות

הגורמים לטראומה

- תאונות דרכים הן 67% מכלל מקרי הטראומה בנשים הרות, שכיחותן גדולה מאוד בטרימסטר האחרון
- פגיעות ישירות בבטן בגלל נפילה
- 10%-31% מכלל מקרי הטראומה הם בשל אלימות
- פציעות חודרות גורמות ל-40%-70% מכלל מקרי תמותה עוברית
- תאונות מקריות.

הגורמים לתמותה של האם

- השכיחה ביותר היא פגיעת ראש
- הלם תת־נפחי
- פגיעה באיברים פנימיים (טחול, כליות, כבד)

גורמים לתמותה של העובר

- תמותה של האם
- הלם של האם - מסתיים במות העובר ב־80% מהמקרים
- היפרדות שליה מלווה במות העובר ב־30% עד 68% מהמקרים.

השפעת האנטומיה על טראומה

ככל שההיריון מתקדם יותר כך הטראומה פוגעת ישירות בעובר כי איברי הבטן של האם מוגנים יותר אך מקום השליה משפיע על פגיעותה. היריון מתקדם דוחק ומשנה את מקומם של איברי בית החזה.

השפעת הפיזיולוגיה על טראומה

- לחץ דם - ירידה קלה בסיסטולי (עד 15 מ"מ"כ (ממ"כ) בדיאסטולי).
- דופק - עלייה בדופק; לא כל טכיקרדיה או ירידה בלחץ דם קשורים להיריון.
- תפוקת הלב - עולה.
- - יש לחץ גדול על הווריד הנבוב התחתון וזה עלול להפיל את לחץ הדם ותפוקת הלב.
- אנמיה יחסית עלולה להחמיר מצב של הלם.
- היפרוונטילציה פיזיולוגית - עלייה בנפח שאיפה, קצב הנשימות נשאר נורמלי.

דגשים באבחון טרום-אשפוזי

- קושי באבחון פגיעה עוברית ישירה ועקיפה
- קושי באבחון פגיעות בטן באישה
- סימנים קליניים של הלם מאוחרים יותר (לאחר 30%-35% אובדן נפח)
- ניסיון מוגבל ומודעות נמוכה של המטפלים

אנמזה נוספת

- מנגנון, קינמטיקה: פגיעה ישירה לבטן, גורם הפגיעה, חגורת בטיחות
- גיל ההיריון, מהלך ההיריון, ממצאים מיוחדים
- הריונות קודמים
- מחלות רקע (רעלת דם [טוקסמיה, toxemia]/סוכרת)
- סוג דם האם (Rh שלילי)
- דימום וגינאלי בגלל היפרדות שליה, קרע בשליה ברחם
- תנועת עובר

הגישה הטיפולית לטראומה בהיריון

- **Airway** - הפריסטלטיקה איטית, העיכול איטי, ולכן יש נטייה גבוהה יותר להקאות (גירויים וגאליים) ולאספירציות.
- **אינטובציה** - חשוב לעשות הפרדה בין מצב שמחייב אינטובציה ומצב שבו אפשר עוד להמשיך בלי טובוס.
- **תרופות הרדמה** - חייבות לעבור דרך גזע המוח וה-BBB [מחסום הדם-מוח (blood brain barrier: BBB)].
- בטרמיסטר הראשון התרופות פוגעות יותר בעובר מאשר בשאר ההיריון.
- **חמצן** - לתת בריכוז גבוה דרך מסכה, גם אם הסטורציה גבוהה, לעובר זה חיוני. אצל נשים רבות יש היפרוונטילציה בגלל הלחץ הנפשי (סטרט) והדאגה לעובר.
- **breathing** - מטפלים ברמה של ALS: ניקוז חזה עם מחט בחשש לחזה אוויר בלחץ, מקום הכנסת המחט באותו מקום אנטומי כמו כל נפגע אחר.
- **circulation** - קשה למצוא וריד בגלל שקיעה של ורידים, שומן, בצקות (בגלל צבירה של נוזלים). לפעמים גם

יהיה יותר קל למצוא ורידים כי הם מתקרבים לפריפריה.

לוח גב - השכבה על הגב של נשים בהיריון גורמת ללחץ על ה־vena cava. זה יגרום לירידה בהחזר הווריד. יש לקבע ללוח גב ולהטות את לוח הגב על צד שמאל.

פינוי - פינוי דחוף ביותר. לא מפנים את כל הנשים לחדר לידה, כדאי להתייעץ עם מוקד מרחבי או חדר מיון.

